

MATAVICIOS · GUÍA PRÁCTICA PARA ADULTOS

Deja el **tabaco**.

Una guía de autoayuda clara para entender tu patrón, preparar un intento y usar apoyos que encajen contigo.

Autoobservación

Plan personal

Apoyo basado en evidencia

Antes de empezar. Este es un material educativo de autoayuda. No diagnostica, no prescribe tratamientos y no sustituye la valoración de medicina, enfermería, farmacia, psicología o psiquiatría.

Úsalo para observar tu patrón, probar cambios pequeños y pedir apoyo cuando lo necesites. No se trata de demostrar fuerza de voluntad ni de seguir una racha perfecta. Se trata de ganar margen de elección.

Cómo está organizado

MÓDULO 0

Empezar con seguridad

MÓDULO 1

Conocer tu patrón

MÓDULO 2

Atravesar un impulso

MÓDULO 3

Pensamientos, emociones y valores

MÓDULO 4

Entorno, personas y apoyo

MÓDULO 5

Elegir apoyos eficaces

MÓDULO 6

Si fumas: volver al plan

MÓDULO 7

Mantener y ajustar

MÓDULO 0

Empezar con seguridad

Una salida realista empieza por decidir qué cambio quieres intentar y qué apoyos necesitas. No necesitas hacerlo todo solo ni hacerlo perfecto.

El objetivo es tuyo

La meta más protectora para la salud es **dejar por completo el tabaco combustible**. Algunas personas eligen una fecha para dejarlo; otras empiezan reduciendo como paso hacia esa fecha o preparando un intento. Elige un siguiente paso concreto, no una promesa heroica.

HERRAMIENTA · MI PUNTO DE PARTIDA

Mi objetivo para los próximos 7 días: dejar / reducir como preparación / observar mi patrón / pedir ayuda profesional.

Mi fecha de abandono o revisión: _____

Una razón que me importa: _____

Un intento anterior me enseñó: _____

Qué puede estar ocurriendo

Fumar suele tener varios componentes a la vez: **abstinencia de nicotina**, rutinas aprendidas y contextos emocionales o sociales. Ninguno habla de un defecto de carácter. Al dejar la nicotina, los síntomas suelen ser más intensos durante la primera semana, especialmente en los primeros días, y habitualmente bajan durante el primer mes. Los deseos pueden reaparecer más adelante ante situaciones asociadas a fumar y su ritmo varía entre personas. [3]

La nicotina se elimina relativamente rápido; la abstinencia y los hábitos aprendidos pueden durar más. Planificar ambos reduce la carga de decidir a cada momento.

Cuándo pedir ayuda desde el principio

Puedes pedir ayuda profesional en cualquier momento, incluso antes de la fecha elegida. Es especialmente útil si quieres valorar medicación, has tenido intentos difíciles, estás embarazada o en lactancia, tomas otros medicamentos, tienes una condición médica o de salud mental, o usas varias sustancias.

SEGURIDAD

Busca atención urgente o usa el número local de emergencias ante ideas de hacerte daño, dolor torácico, falta de aire importante u otros síntomas agudos. Este curso no cubre pautas para vapeadores, tabaco calentado, tabaco sin humo u otros productos de nicotina: pide consejo individualizado si los utilizas.

Antes de cambiar una rutina, conviene verla con detalle. El registro no es un examen: es información para diseñar un plan que se parezca a tu vida.

El mapa: contexto, conducta y efecto

En vez de buscar una única “causa”, observa una cadena completa. Lo que buscas no es una explicación perfecta, sino detectar dónde tienes margen para intervenir.

SITUACIÓN O SEÑAL	QUÉ NOTÉ/PENSÉ	QUÉ HICE	EFFECTO INMEDIATO	COSTE O EFFECTO POSTERIOR
Después del café	“Me apetece una pausa”	Salí a fumar	Pausa, respiración, compañía	Volví con prisa
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Señales frecuentes, no universales

Algunas personas detectan señales corporales, emociones, personas o lugares, rutinas concretas, alcohol u otros momentos del día. No son una lista de “disparadores universales”; tu registro manda. Añade también **qué hace que sea más fácil no fumar**: una persona, un lugar, una actividad, una hora o un día.

PRÁCTICA · REGISTRO BREVE DE IMPULSOS

Durante siete días, anota: hora; situación; intensidad del deseo de 0 a 10; qué alternativa probaste; y qué cambió cinco o diez minutos después. No necesitas escribir mucho: una línea basta.

Una lectura honesta del registro

Al final de la semana, busca dos patrones: **los dos contextos de mayor riesgo** y **una estrategia que haya sido aunque sea un poco útil**. Una estrategia que reduce el deseo de 8 a 6 ya es información; no la descartes porque no haya resuelto todo.

Atravesar un impulso

No necesitas ganar una discusión mental. Necesitas abrir unos minutos entre el impulso y la decisión para poder elegir.

Pausa de cinco pasos

Prueba este guion y adáptalo. No es un tratamiento ni funcionará igual en todas las situaciones.

1. **Nombra:** “Estoy notando ganas de fumar”.
2. **Respira cómodo:** tres o cinco respiraciones lentas, sin forzar ni retener el aire.
3. **Cambia algo:** ponte de pie, aléjate del lugar, bebe agua, mastica chicle sin azúcar o cambia de tarea.
4. **Retrasa la decisión:** elige unos minutos que te parezcan posibles; después vuelve a valorar el deseo.
5. **Elige:** usa el plan si-entonces que preparaste o pide apoyo.

ADÁPTALO A TU SALUD

Caminar o moverte puede servir a algunas personas como pausa si es seguro y adecuado para su salud y movilidad. Detén cualquier práctica que produzca mareo, dolor o malestar. No hay un ejercicio ni un tiempo de espera que garantice que el deseo baje.

Planes si-entonces

Los planes concretos reducen la improvisación. Escribe dos para tus contextos más difíciles.

Mi plan si-entonces

Si _____

entonces primero haré _____

y si el deseo sigue en 7/10 o más, _____

persona o recurso al que puedo acudir: _____

Ejemplo: café

Si termino el café, entonces me levanto, me cepillo los dientes y camino dos minutos antes de decidir.

Ejemplo: pausa laboral

Si alguien sale a fumar, entonces hago una pausa breve dentro o envío un mensaje a mi persona de apoyo.

No existe una alternativa “correcta”

Una pausa sin humo puede ser útil, pero no reemplaza por sí sola el tratamiento de la dependencia. Conserva las opciones que encajen contigo y combina apoyo conductual con atención sanitaria si lo deseas. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

MÓDULO 3

Pensamientos, emociones y valores

Las frases automáticas no son órdenes. Puedes examinarlas con curiosidad y elegir una respuesta más útil sin obligarte a pensar en positivo.

De la frase automática a una alternativa equilibrada

SITUACIÓN	PENSAMIENTO AUTOMÁTICO	QUÉ APOYA/QUÉ CUESTIONA	RESPUESTA EQUILIBRADA
Discusión	“Necesito fumar para calmarme”	Fumar me da una pausa, pero el alivio es corto y puedo probar otras pausas.	“Ahora estoy activado. Puedo alejarme, respirar y decidir después.”

La reestructuración no consiste en sustituir una afirmación absoluta por otra. Consiste en mirar qué pasa en **tu** experiencia y elegir una frase que deje espacio para actuar.

Defusión: notar sin obedecer

A algunas personas les agota pelear contra cada pensamiento de fumar. Puedes probar a decir: **“Estoy teniendo el pensamiento de que un cigarrillo me ayudaría”**. Después vuelve a una acción pequeña del plan. Si esta frase no te ayuda, usa otra herramienta; no necesitas hacerla “bien”.

PRÁCTICA · VALORES EN ACCIÓN

Completa: “Quiero dejar o cambiar mi consumo porque quiero estar más presente en _____. Hoy lo expreso haciendo _____ durante cinco minutos.”

Emociones difíciles sin tratamiento improvisado

Muchas personas notan alivio breve al fumar, a veces porque alivian abstinencia y a veces porque paran un momento. Fumar no es un tratamiento para ansiedad, depresión, tristeza o ira. Crea un menú de opciones personales: música, una ducha, hablar con alguien, una tarea manual, descanso, una caminata si es segura o escribir lo que necesitas. Si una emoción se siente inmanejable, añade apoyo profesional a tu plan.

MÓDULO 4

Entorno, personas y apoyo

Cambiar el entorno no elimina toda dificultad, pero puede hacer que fumar sea menos automático y que tus apoyos estén más cerca.

Añade fricción; añade apoyo

- Retira de casa, coche y lugares frecuentes los cigarrillos, ceniceros y mecheros que no necesitas conservar.
- Prepara una alternativa visible: agua, chicle sin azúcar, una nota con el plan o calzado para una pausa breve.
- Modifica una asociación a la vez: cambia de sitio para el café, termina de comer con higiene dental o toma una ruta distinta.
- Observa si alcohol u otros contextos aumentan el riesgo y decide con antelación cómo los manejarás.

La disponibilidad, las rutinas y las señales influyen en fumar; ajustarlas reduce la carga de decidir a cada momento.

Pedir ayuda sin perder privacidad

Decide tú a quién contarle el intento. Puedes pedir apoyo concreto sin explicar más de lo que quieras:

“Estoy intentando no fumar. Si salimos, prefiero no quedarme en la zona de fumadores.
¿Podemos dar una vuelta o tomar algo dentro?”

Si alguien ofrece un cigarrillo: “No, gracias. Estoy cuidando este cambio.” No debes justificarte ni debatir.

Auditoría de entorno

Mis tres cambios de esta semana

1. Señal que facilita fumar:

Cambio concreto y realista:

2. Persona o situación de riesgo:

Plan de apoyo o salida:

3. Señal que me protege:

Cómo la haré más accesible:

MÓDULO 5

Elegir apoyos eficaces

Pedir apoyo o valorar tratamiento no es “hacer trampa”. Es usar opciones disponibles para una dependencia de salud tratable.

Opciones que merece la pena conocer

Las guías recomiendan ofrecer **apoyo conductual**, intervenciones digitales y tratamientos farmacológicos para dejar de fumar, según la situación de cada persona. El asesoramiento y la medicación suelen ofrecer mejores probabilidades combinados que por separado. [\[1\]](#) [\[2\]](#)

Apoyo conductual

Atención primaria, programas para dejar de fumar, psicología o apoyo telefónico/digital. Ayuda a preparar, seguir y ajustar el intento.

Medicación

La terapia sustitutiva con nicotina y otros medicamentos pueden ser opciones. Un profesional sanitario o farmacéutico valora cuál es apropiada.

Esta guía no incluye dosis, combinaciones ni indicaciones individualizadas. Consulta antes de iniciar o cambiar un tratamiento, especialmente en embarazo/lactancia, con otras enfermedades o si tomas medicación.

Preguntas útiles para una consulta

LLÉVATE ESTA LISTA

“¿Qué opciones de apoyo o tratamiento son adecuadas con mi historial y mis medicamentos?”

“¿Cómo puedo combinar seguimiento y manejo de desencadenantes?”

“¿Qué efectos o señales debería vigilar y a quién contacto si aparecen?”

Recurso público en España

El [Ministerio de Sanidad](#) reúne información para dejar de fumar y orienta hacia recursos sanitarios. Si resides fuera de España, utiliza atención primaria, farmacia o los servicios de salud de tu territorio.

MÓDULO 6

Si fumas: volver al plan

Un cigarrillo o un episodio de consumo no planificado aumenta el riesgo de volver al patrón anterior, pero no borra lo aprendido. La respuesta útil es rápida, concreta y sin castigo.

Desliz no es identidad

En vez de “he fracasado”, prueba: **“He fumado; voy a revisar qué ocurrió y retomar el plan en la siguiente decisión.”** Puede haber influido una combinación de contexto, abstinencia, apoyo disponible y

estrategia. No siempre hay un único disparador que “resolver”.

Tarjeta de retorno en 24 horas

1. **Para y cuídate:** evita castigarte y retira el resto si te resulta posible y seguro.
2. **Registra lo mínimo:** dónde estaba, qué necesitaba, qué señales aparecieron, qué apoyo faltó.
3. **Conecta:** avisa a una persona elegida o pide una cita/apoyo.
4. **Ajusta una cosa:** cambia una señal del entorno o escribe un nuevo plan si-entonces para las próximas 48 horas.
5. **Retoma:** no esperes al lunes ni a una nueva fecha perfecta.

Mi tarjeta de retorno

Persona a la que aviso:

El cambio que haré en las próximas 48 horas:

La frase que me ayuda a volver:

Escalar el apoyo

Si el plan se queda corto, eso es una razón para añadir apoyo, no una prueba de debilidad. Habla con atención sanitaria o farmacia sobre seguimiento y tratamientos. Si aparece una crisis emocional, ideas de autolesión o síntomas físicos importantes, usa atención urgente local.

Mantener y ajustar

No hay una curva obligatoria de recuperación. A muchas personas les disminuyen los deseos con el tiempo; otras los notan ante estrés, alcohol, recuerdos o fumadores. Tener el plan accesible sigue siendo útil.

Revisiones de cinco minutos

CUÁNDO	QUÉ OBSERVO	QUÉ AJUSTO
Día 3	Deseo máximo, abstinencia, apoyo	Una alternativa más fácil
Día 7	Contexto más difícil y herramienta usada	Un plan si-entonces
Día 28	Sueño, ánimo, consumo, tratamiento/seguimiento	Consulta o apoyo adicional si hace falta
Día 90	Qué ha cambiado y qué sigue siendo vulnerable	Plan de mantenimiento

Registra también lo que ha funcionado. El seguimiento sirve para aprender, no para vigilarte.

Ahorro y autorrecompensa

Si te motiva, calcula un ahorro aproximado y destina una cantidad razonable a una recompensa elegida por ti: una actividad, tiempo libre, algo útil o una experiencia alineada con tus valores. No es una medida de éxito ni una obligación económica.

El método en una página

MI SECUENCIA PERSONAL

1. Noto la señal. 2. Hago una pausa cómoda. 3. Cambio contexto o actividad. 4. Uso mi plan si-entonces. 5. Pido apoyo si el deseo sigue alto. 6. Registro y ajusto, sin castigo.

Atención primaria o farmacia

Un buen primer contacto para valorar apoyo conductual, tratamiento y seguimiento de forma individual.

Persona de apoyo

Escribe ahora su nombre y una frase concreta de ayuda que te gustaría recibir.

Emergencias locales

Úsalas ante peligro inmediato, ideas de autolesión o síntomas físicos agudos.

Privacidad

Guarda tus registros donde solo tú o las personas autorizadas puedan verlos.

Fuentes y transparencia

Las herramientas de esta guía se inspiran en enfoques conductuales, cognitivos y de aceptación. La evidencia no permite garantizar un resultado individual ni convertir esta guía en terapia. Las fuentes se incluyen para que puedas comprobar qué se sabe y qué límites tiene.

1. [World Health Organization \(2024\). *WHO clinical treatment guideline for tobacco cessation in adults*.](#)
2. [Centers for Disease Control and Prevention \(2024\). *Clinical interventions to treat tobacco use and dependence among adults*.](#)
3. [National Cancer Institute. *Tips for coping with nicotine withdrawal and triggers*.](#)
4. [Chang J, et al. \(2025\). *The effectiveness of cognitive behavioral therapy for smoking cessation: a systematic review and meta-analysis*. Journal of Behavioral Medicine.](#)
5. [Cochrane. *Can nicotine replacement therapy help people quit smoking?*](#)
6. [NICE \(2025\). *Tobacco: preventing uptake, promoting quitting and treating dependence*.](#)

Matavicios · Material de educación y autoayuda para adultos. Versión editorial revisada: septiembre de 2026. Si digitalizas tus ejercicios, protege tu privacidad: no compartas detalles sensibles en espacios no moderados y revisa dónde se guardan tus datos.